

Au niveau neurologique, les plexus vertébrales se composent d'essentiellement 4-5 parties. Vous avez ce qu'on appelle le système médulaire, profond, le système des veineux vertébrales internes entre la durmère et le sinus duralis, et puis le plexus veineux vertébral externe. On a encore les systèmes diploïdes et les émissaires, qui sont un peu encore plus spécifiques au niveau du crâne. Tu as un plexus médulaire, tu as aussi tout un plexus interne au niveau ici, et ça c'est très intéressant, c'est tout un réseau, et surtout le sinus pterygoïdien, ici, qui est une phase de congestion. Il faut apprendre à aller libérer ce système, c'est une soupape, c'est comme s'il y avait un engorgement. Alors quand vous avez une cervicalgie chronique, ou quelqu'un qui vient avec un corticulier aigu, ce sont souvent des compressions veineuses. Tu regardes une coupe d'un nerf, le périnève, l'endonèvre, l'épinève. Là-dedans, dans cette coupe d'un nerf, on se retrouve avec des petits vaisseaux, là-dedans. Et c'est eux qui peuvent congestionner et comprimer le système neuronal, neurologique. Donc nous, on a un rôle où on peut décongestionner ça, une dyscopathie. En fait, c'est des stases, elles libèrent les cytokines, elles libèrent une acidité qui commence à détruire le système, rééquilibrer les pressions. Et ça, c'est aussi le sinus duralis, c'est en continuité le plexus vertébral. Le sacrum peut soulager vos maux de tête. Comme tout, ce sang veineux vient se mettre dans ce qu'on appelle le sinus rectus, sagittale supérieure, sagittale inférieure, sinus droit et transversal. Comme si ça se mettait là. Et c'est pour ça que c'est en rapport aussi avec quelque chose de très intéressant, au niveau de mon quatrième ventricule, c'est le trou de Mangadi. Et qu'est-ce que c'est ? C'est l'ouverture, c'est presque une pulsation qu'on va retrouver avec le système LCR. En libérant, en libérant depuis la périphérie vers la profondeur tout ce système, vous allez réouvrir tous les champs vasculaires et redrainer tout le système vasculaire aussi. Carotide, carotide, artère vertébrale, porte de sortie, tout ce drainage

des sinus via le plexus vertébral. C'est donc un sacrum libre. Les veines pelviennes et celles des membres inférieurs sont une unité fonctionnelle. Ça veut dire qu'un déséquilibre de mes membres inférieurs, pieds, genoux, bassins ici, intervient sur le système urogenital. Je donne un exemple. Chaque fois que je marche, je fais un drainage. Avec la semelle de légeard. J'ai un espèce de diaphragme en dessous qu'on appelle l'articulation scaphoïde-cuboïde. Eh bien, première chose qu'on fait pour vérifier dans les troubles du petit bassin chez la femme, on va vérifier le pied. On va libérer le pied, comme on peut, pour qu'on ait de nouveau cette force de retour. Sinon, ça donne une stase. Il y a des femmes qui viennent avec des douleurs de membres inférieurs. Eh bien, en fait, si elle est en dedans du nerf, il faudra penser à aller voir le système. Si ce n'est pas urogenital. Ça, c'est aussi, on en avait parlé, certaines voies de suppléance ne sont que la réapparition d'un état circulatoire constaté chez le fœtus et qui régressent dans des conditions physiologiques. Dans une rétroversion utérine, tu as souvent des congestions qui se font. Attention. Il existe en fait une pauvreté de valve qui fait qu'il y a une circulation dans les deux sens. Vous vous souvenez, je vous expliquais qu'il y avait cette circulation veineuse qui pouvait changer. Ça prenait d'autres directions. Je pars. Je pars par là. Mais là, j'ai une congestion. Je repars par là. Et je peux stagner. Je peux créer des espaces de congestion locale, prostate, etc. Ce sont des congestions qui vont faire. Et je peux repartir sur un autre chemin. La pression abdominale influence le trajet du sang veineux, comme ce que je viens de dire. Ainsi, lorsque la pression abdominale augmente, qu'est-ce qu'elle se fait ? Elle va se diriger vers quoi ? Vers les plexus vertébraux. Donc, congestion vertébrale. Lombalgie. Vous avez des lombalgies d'origine digestive. Souvent, il y a des gens, ils viennent chez vous, mais ils n'ont rien porté. Ils sont calés. En fait, il faut rétablir les pressions pour soulager le foie, pour redonner l'équilibre

dynamique ici. Les troubles de la circulation veineuse seraient la cause de dyspanurie profonde, persistant dans les heures suivant le rapport, de dysménorrhée, de constipation, de ténésme, de l'atteinte générale, des asthénies, des tendances d'esprit tifs et de l'irritabilité émotionnelle. Regardez tout ce que ça peut engendrer. La grande clé, c'est la pompe diaphragmatique, à la fois vasculaire, à la fois artérielle et à la fois lymphatique. Le développement du système vasculaire a comme conséquence, qu'il y a une pression sanguine qui va se faire. J'ai le système capillaire. À un moment donné, il y a cette pression. Et en fait, ça va créer les exudats. C'est le réseau intercellulaire. Et ce réseau-là va créer, en fait, de nouvelles trajectoires. Essentiellement, des trajectoires d'abord purement longitudinales ici, avec tout un réseau très important qu'on appelle la citerne de Pequet ou la citerne de Schiele, avec surtout une grande résorption au niveau de la soupe clavière gauche. Les psoas, avec le fascia périrénal, drainent jusqu'à un litre, un litre et demi de lymphe par jour par ces mouvements. Le psoas, ça correspond en fait à un organe qui est assez épais et qui peut prendre les toxines. C'est pour ça que je peux me verrouiller à cause de mon psoas. C'est une surcharge toxémique qui ne se libère pas de mon péritoine et qui se fout dans mon système veineux, qui se refout après dans mon système lymphatique. Et je ne sais pas drainer. Et vous avez un petit muscle qui ressemble au niveau de la nuque au psoas, l'angulaire de l'homoplate. Il est épais comme ça. Si vous le disséquez, c'est comme s'il s'insère de la même façon et il vient se déposer comme ça. C'est un muscle épais comme ça. C'est aussi un muscle qui reprend la toxicité. N'oubliez pas que je considère, moi, qu'il y a sept diaphragmes. Les pieds, les genoux, le petit bassin. Le thoraco ici, Simpson. Le cervelet et tout l'équilibre avec la base du crâne. Et puis mes pariétaux ici. Parce qu'ici, qu'est-ce que j'ai au-dessus ? J'ai un espace de drainage le plus important pour le système LCR, résorption. Il faut que vos pariétaux respirent. C'est des

panneaux solaires. Ils doivent prendre la lumière. Les radius, c'est des os solaires. Ensuite, on va réintégrer tout ça avec le cerveau, avec les différents liens qu'on a vus. On va réintégrer ça finalement avec le système vitellin, le système ombilical, le choc apexien, pour relibérer le cerveau aussi.